STAT3 変異を認めた T 細胞大顆粒リンパ性白血病の 1 症例

◎永谷 大輔[1)]、南 勇輝[1)]、池内 直美[1)]、伊達 諒[1)]、梁瀬 博文[2)]
静岡県立 静岡がんセンターSRL[1)]、静岡県立 静岡がんセンター血液管理室[2)]

【はじめに】T 細胞大顆粒リンパ性白血病(以下 T-LGLL)は、明らかな原因のない 6 ヵ月以上持続する末梢血の顆粒リンパ球増殖症で絶対数が 2000～20000/μL とされ、免疫刺激の持続が著明な好中球減少や貧血に関与する。STAT3 変異は T-LGLL に特異的な分子マーカーとして注目され、補助診断における有用性が期待されている。

【症例】40 代男性、10 年前に健診でリンパ球絶対数の増加を指摘され、慢性リンパ性白血病(以下 CLL)疑いで経過観察となっていた。2 ヶ月ほど前から易疲労感が増悪し、CT にて中等度の脾腫を認め、精査・加療目的にて当院紹介。

【検査所見】末梢血：WBC 9500/μL、Hb 7.8g/dL、PLT 24.2×104/μL、Reti 2.4% 血液像目視：Stab 0.0%、Seg 4.5%、Eo 0.0%、Ba 0.0%、Mo 4.5%、Ly 89.5%、Aty-Ly 0.5%、Ly の 75.5%に大顆粒リンパ球(以下 LGL)を認める(LGL# 6591/μL)。生化免疫学検査：LD 235U/L、CRP 0.02mg/dL、sIL2R 446U/mL 骨髄像所見：リンパ球系細胞を 50.2%認め、リンパ球の 60.6%に LGL を認める。FCM：gate(1)58.0%細胞集団 CD2(99.2%), CD3(98.6%),CD4(15.8%), CD5(68.9%),CD7(96.3%), CD8(82.9%),CD11c(53.8%), CD16(40.1%),CD56(5.1%), TCR-αβ(96.5%), cyCD3(97.5%) 染色体検査:47,XY,+Y[1]/46,XY[19] T 細胞レセプターβ鎖 Cβ1 再構成：遺伝子再構成あり ヘムサイト：STAT3 変異あり

【考察】STAT3 変異を認めた T-LGLL を経験した。LGL には、T 細胞と NK 細胞があり、T 細胞性が T-LGLL に相当し、NK 細胞性は慢性 NK 細胞リンパ増殖異常症(以下 CLPD-NK)に相当する。形態から両者の鑑別は難しく、細胞の起源、分子学的特徴、臨床像が重要となる。両者は STAT3 変異による経路活性が明らかにされ、T-LGLL は 30～40%に認め、CLPD-NK よりも頻度が高い。STAT3 変異を認める T-LGLL は、好中球減少や関節リウマチを高頻度で認めることが報告されている。本症例では形態から T-LGLL と CLPD-NK の鑑別が困難であったが、STAT3 変異の検出が T-LGLL の診断を支持し、併発した好中球減少とも一致した。STAT3 変異解析が補助診断および臨床評価に有用であることが示唆された。連絡先：055-980-5686